

בעיות לב אצל ילדים

ברדיקרדיה (דופק איטי)

בעיה הנפוצה אצל ילדים עקב היפוקסמיה, יתר לחץ דם, חמצנת או גירוי וגאלי כלשהו. קצב הלב ירד מתחת לערך הנורמלי: תינוקות וילדים מתחת ל־60 בדקה.

הטיפול

- יש לחמצן ולאוויר את הילד
- שומרים על חום גוף הילד
- להיות מוכן לכשל לבבי ולהתחיל בעיסוי לב כאשר קצב הלב פחות מ־60 לדקה בתינוקות וילדים
- מחברים למוניטור
- יש לשקול אינטובציה
- לשקול טיפול תרופתי

דום לב

דום לב בילדים קורה בגלל סיבוך של ברדיקרדיה או בשל הפרעה אחרת מולדת. חשוב להבין את סיפור המקרה, מה קרה לילד לפני כן. ילד עם דום לב יהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה; חיבור למוניטור יאמת את האבחנה תוך כדי תחילת החייאת לב ריאה (CPR).

טכיקרדיה עלי־חדרית

טכיקרדיה עלי־חדרית היא פעימות לב מהירות בגלל גירוי חשמלי מהיר שמקורו מעל חדרי הלב. זו הפרעה שקיימת אצל תינוקות וילדים שסובלים בדרך כלל מבעיית לב כלשהי. קצב ליבם יכול להגיע עד 200-300 פעימות בדקה. תינוקות יכולים לחיות עם קצב לב זה למשך זמן, אך נזק לשריר הלב וכשל לבבי יגיע תוך שעות.

סימנים

רואים שהילד כחלוני או חיוור, ללא תיאבון או סובל מבחילות והקאות; סימני הלם עלולים להופיע. ילדים שיכולים להתבטא יתלוננו על הרגשת חולשה, טשטוש לקראת עילפון.

טיפול

- חיבור למוניטור, סימנים חיוניים, חמצן
- להתכונן לביצוע החייאה אם צריך, פינוי דחוף ולדווח לבית החולים.

טבלה 21.16 תרופות בהחייאת ילדים

תרופות	מינון	הערות
אדרנלין בדום לב או ללא דופק (epinephrine for asystole or pulseless arrest)	מנה ראשונה: לווריד/ עצם 0.01 מ"ג/ק"ג (1:10.000, 0.1 מ"ל/ק"ג) לטובוס: 0.1 מ"ג/ק"ג (1:1000, 0.1 מ"ל/ק"ג)	יש להיות ערים למינון החומר המשמר (אם יש בתמיסה), כשמתמשים במינונים גבוהים
גלוקוז (glucose)	0.5-0.2 גרם/ק"ג בריכוז מקסימלי 25% בתינוקות עד חצי שנה ריכוז 10%	לטיפול בהיפוגליקמיה
דופמין הידרוכלוריד (dopamine) (hydrochloride)	2-20 מק"ג/ק"ג/דקה	במינון < 15-20 מק"ג/ק"ג/דקה שולטת פעילות אלפא-אדרנרגית
נלוקסון (naloxone)	עד גיל 5 במשקל נמוך מ-20 ק"ג: 0.1 מ"ג/ק"ג, כל 3-2 דקות גיל 5 שנים או משקל יותר מ-20 ק"ג: 2.0 מ"ג/ק"ג, כל 3-2 דקות	
סודיום ביקרבונט, נתרן ביקרבונט (sodium bicarbonate)	1 מא"ק [מיליאקווילנט]/ק"ג למנה	לא כלול בהנחיות PALS עדכניות.
קלציום גלוקונט 10% (calcium gluconate 10%)	100-50 מ"ג/ק"ג מינון מרבי למנה: 1 גרם	מתן איטי תוך ניטור ברדיקרדיה אין לתת יחד עם ביקרבונט
קלציום כלוריד (calcium chloride 10%)	20 מ"ג/ק"ג	מתן איטי תוך ניטור ברדיקרדיה אין לתת יחד עם ביקרבונט (דורש עירוי פריפרי גדול)

החזר נוזלים לילדים

הסיבה השכיחה להלם אצל ילדים ותינוקות היא איבוד נוזלים. טיפול מוצלח באמצעות נוזלים מצריך הערכה נכונה של מצב הילד המטופל והזלפת נוזלים בנפח מספיק לשמירת פרפוזיה היקפית יעילה. לעיתים הטיפול בנוזלים בשלבי ההחייאה הראשונית לא יהיה מספיק ויש להמשיכו עד שרואים שסימני ההלם נעלמים. בדרך כלל העמסה ראשונית בהחייאה תיעשה מהר ככל האפשר על ידי הזלפה של 20 סמ"ק/לק"ג של תמיסה קריסטלואידית ואיזוטונית לווריד. יש גם אופציה לתת נוזלים בעירוי תוך-גרמי. לאחר העמסת נוזלים זו יש לעשות הערכה מחודשת, ואם סימני ההלם עדיין ניכרים במטופל יש לתת מנת העמסה נוספת. אפשר לחזור על מנות אלו עד לנפח כולל של 60-80 סמ"ק/לק"ג.

- תמיסות קריסטלואידים מגדילות את נפח הנוזלים בכלי הדם רק לדקות ספורות, ולפיכך תיקון הנפח התוך-כלי נמשך לזמן קצר, ולכן דרושות מנות חוזרות של תמיסה לשם שמירה על הנפח התוך-כלי.
 - לעומתם הקולואידים נשארים שעות אחדות בדם, אך הם גורמים לתופעות אלרגיות ולסיבוכים אחרים. לא הוכח יתרון במתן תמיסות קולואידים על פני מתן תמיסות אלקטרוליטים (על התמיסות ראו הרחבה בפרק 10).
 - אם משקל הגוף ידוע אפשר להעריך את נפח הדם של המטופל.
- נפח הדם הוא בדרך כלל 85 סמ"ק/לק"ג לתינוקות, ובילדים 75 סמ"ק/לק"ג. יש להעריך את כמות הדם שאיבד המטופל לפי מצבו הקליני כולל קצב דופק, לחץ דם סיסטולי, מצב ההכרה, פרפוזיה פריפריית ועוד. יש לזכור שירידת לחץ דם אינה נצפית בדרך כלל בתינוק שאיבד פחות מ-25% מנפח דמו.

טבלה 21.17 סימנים מערכתיים המצביעים על איבוד דם בילד פצוע (או בהלם היפוואלמי)

איבוד של יותר מ־45% נפח דם	איבוד של 25%-45% נפח דם	איבוד כ־25% נפח דם	
• ירידת לחץ דם • טכיקרדיה עד ברדיקרדיה	• דופק חלש ומהיר	• דופק חלש ומהיר	לב
• אין תגובה לכאב • חוסר הכרה	• טשטוש הכרה • תגובה מעומעמת לכאב	• ישנוני • מבולבל	מוח
• חיוור וקר	• כיחלון • קצות הגפיים קרים	• קר ולח	עור
• ללא מתן שתן	• תפוקת שתן מינימלית	• ירידה בתפוקת שתן	כליה